

Universidade do Vale do Itajaí – Campus Balneário Camboriú

Curso: Arquitetura e Urbanismo

Disciplina: Trabalho final de Graduação I

Docentes: Stavros Wrobel Abib e Carolina Rocha Carvalho

Discente: Laysa Baumgartner Muller

Introdução

Este Trabalho Final de Graduação aborda a relação entre alimentação, saúde e ambiente construído, compreendendo a arquitetura como um agente ativo na promoção do bem-estar físico, emocional e social. Diante do aumento de doenças crônicas não transmissíveis e restrições alimentares severas, propõe-se um Centro de Saúde Integrativa voltado à adaptação alimentar. O foco são indivíduos que necessitam reestruturar seu cotidiano e sua relação com o alimento, por meio de um ambiente de permanência temporária que suporte novos hábitos de cuidado, reduzindo a exclusão social e promovendo pertencimento através de uma comunidade terapêutica.

A alimentação vai além da função biológica, sendo também um elemento cultural, social e simbólico. Ao longo do tempo, seu comportamento foi influenciado por fatores físicos, psicológicos e pelo ambiente. Entretanto, a Revolução Industrial e a globalização provocaram uma ruptura nesse sistema, com a predominância dos alimentos ultraprocessados (AUP), fragilizando a relação com a origem dos alimentos e contribuindo para o aumento de doenças crônicas (PEREIRA, 2013). Paralelamente, observa-se o crescimento de condições como alergias alimentares, que afetam cerca de 3,2 milhões de crianças brasileiras, além de intolerâncias e doenças inflamatórias intestinais (ASBAI, 2023), impactando diretamente a vida emocional e social dos indivíduos.

Embora a saúde esteja sendo ampliada pelas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), os espaços de cuidado ainda seguem predominantemente o modelo biomédico tradicional. Esses ambientes, muitas vezes padronizados e impessoais, podem aumentar o estresse e reduzir a sensação de acolhimento (MULLER & NOGUEIRA, 2026), evidenciando a

necessidade de abordagens arquitetônicas mais sensíveis, que considerem ambiência, conforto e bem-estar.

Além disso, o ato de comer envolve dimensões biológicas, emocionais, sociais e ambientais, que influenciam diretamente a qualidade de vida (LIMA, 2020). Ainda assim, muitos espaços de saúde permanecem rígidos e pouco sensoriais, não favorecendo permanência, acolhimento ou convivência, e negligenciando aspectos como contato com a natureza e experiência coletiva.

Dessa forma, evidencia-se a pouca exploração da arquitetura como suporte à reabilitação alimentar e à promoção da saúde, especialmente na articulação entre espaço, cuidado e experiência do usuário, além da escassez de ambientes de saúde que sejam verdadeiramente acolhedores e aconchegantes, capazes de promover conforto, permanência e bem-estar.

Assim, o propósito deste trabalho é repensar os espaços de cuidado em saúde por meio da proposta de um Centro de Saúde Integrativa voltado à adaptação alimentar de indivíduos com doenças e restrições alimentares. O projeto busca demonstrar como a ambiência arquitetônica, associada a uma comunidade terapêutica, pode favorecer acolhimento, pertencimento, convivência e suporte mútuo, promovendo uma relação mais saudável entre o sujeito, o alimento e o ambiente construído, de forma integrada entre os aspectos físicos, emocionais e sociais.

Justificativa Social

O crescimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e das condições relacionadas à alimentação evidencia um importante problema da saúde pública contemporânea (OMS, 2023). Associado a esse cenário, observa-se o aumento de doenças e intolerâncias alimentares, como Esofagite Eosinofílica, Doença Celíaca e doenças inflamatórias intestinais, que demandam acompanhamento contínuo e mudanças profundas nos hábitos cotidianos.

Além disso, muitas dessas condições ainda possuem baixa disseminação de informações na sociedade, o que dificulta o diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento adequado e a adaptação dos indivíduos às novas rotinas alimentares. Em diversos casos, os tratamentos e medicamentos específicos são recentes ou

ainda pouco acessíveis, tornando o processo de cuidado e inclusão social ainda mais desafiador para os pacientes e suas famílias.

A Esofagite Eosinofílica apresenta prevalência estimada em aproximadamente 1 caso para cada 2,3 mil habitantes (FLEURY, 2024), enquanto a Doença Celíaca afeta cerca de 78 milhões de pessoas no mundo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE GASTROENTEROLOGIA, 2023). No Brasil, aproximadamente 84 milhões de adultos apresentam algum grau de intolerância à lactose (BAYER, 2018), e estima-se que entre 3,2 e 4,3 milhões de crianças em idade escolar convivam com alergias alimentares (ASBAI, 2023).

Essas patologias ultrapassam a dimensão fisiológica, impactando diretamente a vida social dos indivíduos, uma vez que restringem a convivência em espaços coletivos, eventos e ambientes de alimentação compartilhada, gerando situações de exclusão, insegurança alimentar e fragilização do sentimento de pertencimento social.

Além disso, o aumento dessas ocorrências relaciona-se às transformações dos padrões alimentares contemporâneos, marcados pelo elevado consumo de alimentos ultraprocessados e pelas alterações na microbiota intestinal. Esses fatores reforçam o caráter multifatorial e crescente desse cenário como questão de saúde pública.

Nesse contexto, a reabilitação alimentar envolve não apenas aspectos nutricionais, mas também suporte emocional, adaptação de rotinas e reconstrução da relação social com o alimento. Entretanto, ainda há carência de espaços que integrem orientação nutricional, suporte terapêutico e ambientes adequados ao cuidado contínuo, evidenciando uma lacuna na infraestrutura de saúde e nas potencialidades da arquitetura como suporte aos processos de acolhimento, permanência e bem-estar dessa população.

Justificativa Técnico-Científica

O presente trabalho fundamenta-se na compreensão do ambiente construído como um agente terapêutico ativo, capaz de influenciar diretamente os processos de recuperação e a qualidade de vida dos usuários. Essa abordagem sustenta-se na Teoria do Design de Suporte, de Roger Ulrich (1991),

que estabelece a importância de estratégias de ambiência, conforto sensorial e integração com a natureza para a redução do estresse em ambientes de saúde. Dessa forma, a proposta explora como a arquitetura pode atuar além da função estética, servindo como ferramenta de suporte psicossocial e promotora de bem-estar (ULRICH, 1991).

As transformações dos padrões alimentares contemporâneos, marcadas pelo aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, estão cientificamente associadas a alterações metabólicas e processos inflamatórios relacionados ao desenvolvimento de alergias e doenças crônicas (LIMA, 2020). Paralelamente, os modos de vida urbanos contemporâneos e a crescente industrialização da alimentação evidenciam a relação entre saúde, ambiente e qualidade de vida, reforçando a necessidade de abordagens integradas no cuidado aos indivíduos com restrições alimentares.

Nesse contexto, a arquitetura deixa de atuar apenas como suporte físico e passa a integrar o processo terapêutico, uma vez que as respostas físicas, emocionais e sensoriais dos usuários são influenciadas pelos estímulos do espaço. Contudo, observa-se que, apesar dos avanços na humanização da saúde, ainda são escassas as pesquisas e diretrizes projetuais que relacionam arquitetura e reabilitação alimentar.

Além disso, a proposta amplia o debate sobre espaços destinados à reabilitação alimentar, tema ainda pouco explorado no campo arquitetônico, articulando elementos como biofilia, iluminação natural, conforto ambiental, hortas terapêuticas e espaços de convivência como instrumentos de promoção da saúde e bem-estar.

Justificativa territorial

A escolha da região da Foz do Rio Itajaí para a implantação do Centro de Saúde Integrativa fundamenta-se em sua relevância como um dos principais eixos urbanos e econômicos do litoral catarinense. A região caracteriza-se pelo intenso processo de urbanização, elevado fluxo populacional, crescimento contínuo e forte dinamismo econômico e turístico, fatores que contribuem para o aumento das demandas relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar da população.

Além disso, a região concentra importantes redes de mobilidade, serviços e infraestrutura urbana, exercendo papel estratégico no atendimento de diferentes municípios do litoral de Santa Catarina. Apesar dessa centralidade regional, observa-se a ausência de equipamentos especializados que integrem assistência em saúde, educação alimentar e reabilitação nutricional em um único sistema espacial, evidenciando uma lacuna na oferta de espaços voltados ao acompanhamento contínuo, à adaptação alimentar e à permanência terapêutica.

Nesse contexto, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam aproximadamente 70,8% dos óbitos em Santa Catarina (SES/SC, 2023), reforçando a necessidade de estratégias preventivas e de promoção da saúde que ultrapassem o modelo biomédico tradicional. Embora existam dados nacionais relacionados ao crescimento das restrições alimentares e doenças associadas à alimentação, ainda são limitadas as informações sistematizadas em escala regional sobre essas condições no estado de Santa Catarina, evidenciando a necessidade de maior atenção institucional e de equipamentos voltados ao suporte contínuo dessa população.

Dessa forma, a implantação do Centro de Saúde Integrativa justifica-se como resposta a uma carência territorial de infraestrutura especializada em saúde alimentar. O projeto propõe um equipamento arquitetônico de suporte contínuo, voltado ao acolhimento, à convivência, à educação alimentar e à promoção do bem-estar, contribuindo para ampliar a rede regional de cuidado e qualidade de vida no litoral catarinense.

Objetivo Geral

Projetar um Centro de Saúde Integrativa voltado à reabilitação alimentar que englobe as necessidades físicas, emocionais e sociais de indivíduos com restrições alimentares, consolidando o ambiente construído como suporte ao bem-estar e à adaptação de novos hábitos.

Objetivos Específicos

Demonstrar como a criação de espaços de permanência e convivência fortalece as redes de apoio e promove o pertencimento entre usuários com condições alimentares restritivas;

Validar a eficácia da arquitetura como suporte ao cuidado integral através da articulação entre estímulos sensoriais e conforto ambiental, favorecendo a reabilitação alimentar.

Estabelecer diretrizes espaciais para ambientes de aprendizado que estimulem a autonomia e a reconstrução da relação entre o sujeito e o alimento.

Revisão literária

A relação entre arquitetura, saúde e bem-estar tem sido amplamente discutida a partir de abordagens que compreendem o ambiente construído como um elemento capaz de influenciar as experiências físicas, emocionais e sensoriais dos indivíduos. Nesse contexto, autores como Pallasmaa (2011) criticam a predominância da experiência puramente visual na arquitetura contemporânea, defendendo espaços que estimulem a percepção multissensorial por meio da luz, dos materiais, das texturas, dos sons e das relações táteis. Para o autor, a arquitetura deve envolver o corpo e os sentidos, fortalecendo vínculos emocionais e a sensação de pertencimento.

Da mesma forma, Zumthor (2006) aborda o conceito de atmosfera arquitetônica, compreendendo a experiência espacial como resultado da interação entre elementos como materialidade, iluminação, proporção, temperatura e acústica. Esses aspectos influenciam diretamente a forma como os usuários percebem e vivenciam os espaços, tornando a arquitetura capaz de despertar sensações de acolhimento, conforto e permanência.

No campo da arquitetura voltada à saúde, Ulrich (1991) desenvolve a Teoria do Design de Suporte, que compreende o ambiente construído como um agente terapêutico ativo. O autor destaca que fatores como contato com a natureza, privacidade, conforto ambiental e suporte social contribuem para a redução do estresse e para a promoção do bem-estar físico e emocional. Complementando essa perspectiva, Kellert (2015) defende a biofilia como estratégia projetual que fortalece a conexão entre ser humano e natureza, promovendo benefícios psicológicos, cognitivos e fisiológicos.

As discussões sobre ambiência terapêutica e humanização dos espaços de saúde reforçam a importância de ambientes mais acolhedores e sensoriais,

especialmente diante da predominância do modelo biomédico tradicional (MEDEIROS, 2024). Nesse cenário, a integração entre arquitetura, paisagismo e práticas integrativas amplia as possibilidades de criação de espaços voltados ao cuidado integral e à promoção da qualidade de vida, sendo fundamental para o acolhimento de indivíduos com restrições alimentares e necessidades de reabilitação.

A alimentação também pode ser compreendida como uma experiência social, emocional e sensorial, influenciada pelas características do ambiente em que ocorre. Espaços destinados ao preparo, ao compartilhamento e à aprendizagem alimentar tornam-se, portanto, elementos relevantes nos processos de adaptação e reabilitação alimentar, nos quais o ambiente acolhedor e a convivência entre indivíduos com experiências semelhantes podem favorecer o pertencimento, o suporte coletivo e tornar o processo de tratamento mais leve e facilitado, contribuindo para a construção de hábitos mais saudáveis.

Como reforça Lima (2012), “Ninguém se cura somente da dor física; é preciso curar também a dor emocional e espiritual, em um ambiente mais humano, sem abrir mão da funcionalidade”, evidenciando a importância de uma arquitetura que vá além da funcionalidade técnica e considere a dimensão humana e simbólica do cuidado.

Conceitos

Conceito 01: Atmosfera Arquitetônica

A atmosfera arquitetônica refere-se à forma como os elementos espaciais influenciam a percepção imediata e a resposta emocional do usuário ao entrar no ambiente (ZUMTHOR, 2006). Este conceito foca no acolhimento psicológico e na quebra da frieza hospitalar tradicional. Conforme Zumthor, a arquitetura deve ser capaz de comunicar sensações de calma e segurança por meio da luz, da temperatura e das proporções. No Centro de Saúde Integrativa, a atmosfera atua como o primeiro suporte ao cuidado, criando um ambiente de desaceleração que reduz a tensão emocional do indivíduo antes mesmo do início das práticas terapêuticas.

Aplicação Projetual: focado no impacto visual e espacial da chegada e recepção. Utiliza-se o controle da iluminação zenital filtrada e o desenho de proporções de escala humana para criar uma transição suave entre o exterior urbano acelerado e o interior terapêutico acolhedor.

Conceito 02: Arquitetura sensorial

A arquitetura sensorial compreende o espaço como uma experiência multissensorial, valorizando não apenas a visão, mas também os aspectos táteis, sonoros, térmicos e olfativos na relação entre corpo e ambiente (PALLASMAA, 2011). Para o autor, a arquitetura deve envolver o corpo como uma extensão da experiência humana, em que os sentidos constroem a percepção do espaço e fortalecem o vínculo emocional com o ambiente.

Nesse sentido, Pallasmaa (2011) destaca que a arquitetura deve ser vivida pelo corpo inteiro, onde materiais, luz e proporções atuam na construção de atmosferas significativas e na sensação de pertencimento. Essa abordagem critica a predominância do visual na arquitetura contemporânea e propõe uma experiência espacial mais integrada e sensível.

No contexto da reabilitação alimentar, esse conceito permite que o usuário reconstrua sua relação com o alimento e com o ambiente por meio da estimulação sensorial gradual, consciente e segura, ampliando a percepção corporal como parte do processo terapêutico.

Aplicação projetual: Focada nos sentidos e na horta. O projeto incorpora jardins sensoriais e hortas aromáticas integradas, onde o aroma das ervas e a textura da vegetação atuam como suporte direto à educação sensorial e à reconexão com o alimento.

Além disso, materiais com diferentes texturas, variações de luz natural e percursos espaciais mais suaves contribuem para uma vivência multissensorial contínua, reforçando a relação entre corpo, espaço e alimento dentro do processo terapêutico.

Conceito 03: Design Holístico

O design holístico no Centro de Saúde Integrativa compreende o ambiente construído como um sistema integrado, no qual arquitetura, usuário e

contexto alimentar atuam de forma interdependente no processo de cuidado. Diferente de abordagens fragmentadas da saúde, parte da compreensão do indivíduo em sua totalidade, considerando suas dimensões físicas, emocionais e sociais. Nesse sentido, o espaço deixa de ser apenas suporte funcional e passa a atuar como mediador no processo de cuidado e adaptação alimentar.

A qualidade espacial resulta da articulação entre natureza, conforto ambiental, materialidade e estímulos sensoriais, configurando um sistema contínuo de suporte ao bem-estar e às experiências do usuário.

Aplicação projetual: O conceito materializa-se na organização sistêmica dos fluxos e no desempenho ambiental do edifício. A organização espacial elimina a fragmentação institucional ao articular áreas clínicas, educativas e de convivência em um percurso contínuo e humanizado. Estratégias como a ventilação cruzada e o uso de materiais atóxicos não são apenas recursos técnicos, mas componentes de um sistema de suporte à saúde que garante a qualidade do ar e o equilíbrio metabólico. A integração biofílica, através das hortas e jardins, consolida a infraestrutura como um território de aprendizado e reconexão entre o indivíduo, a natureza e o alimento.

Síntese conceitual

A articulação entre os conceitos de Atmosfera Arquitetônica, Arquitetura Sensorial e Design Holístico estabelece a base teórico-projetual do Centro de Saúde Integrativa voltado à adaptação alimentar em pacientes com doenças voltada para alimentação. Em conjunto, esses conceitos reforçam a compreensão da arquitetura como agente ativo nas experiências de cuidado, acolhimento, permanência e bem-estar, promovendo ambientes mais humanizados e sensoriais.

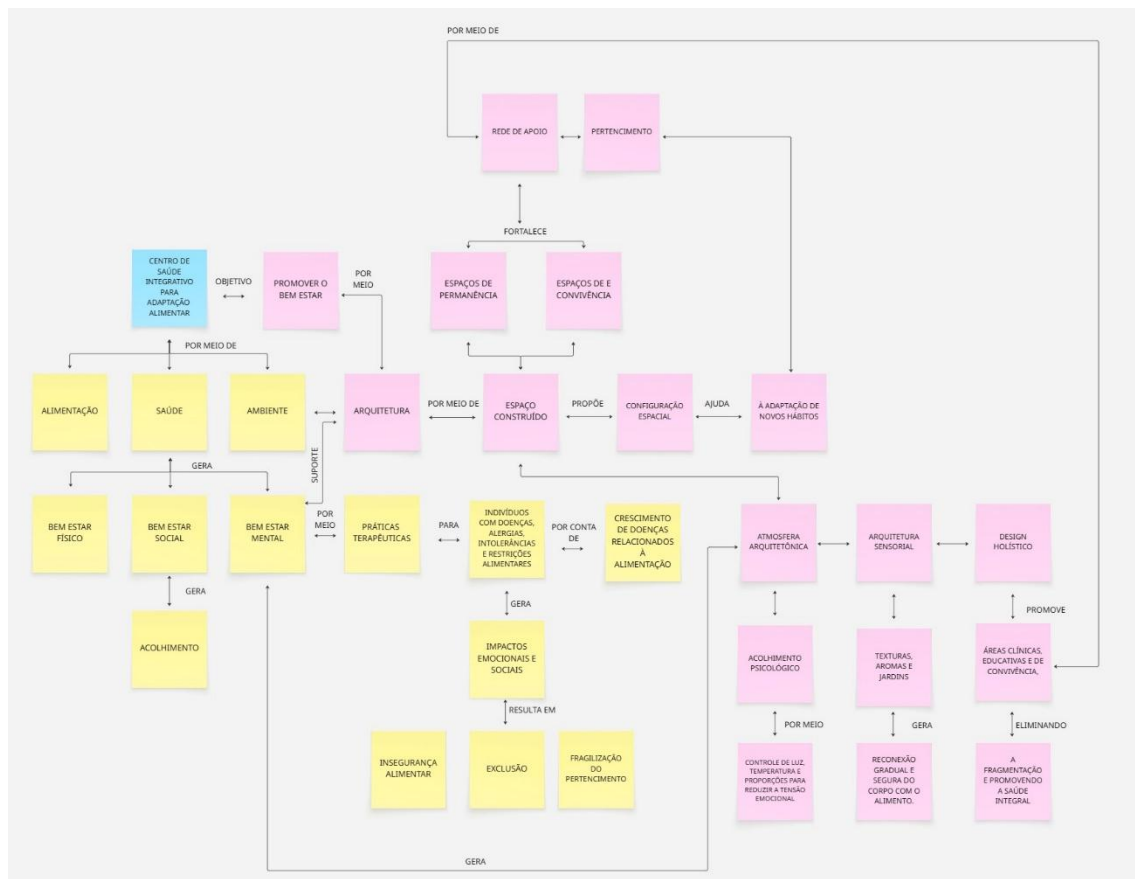
A Atmosfera Arquitetônica constitui a camada inicial da experiência espacial, sendo responsável pela criação de condições de conforto emocional e segurança por meio da luz, materialidade, acústica e proporções. Esses elementos contribuem para reduzir a tensão associada ao ambiente, favorecendo um estado de desaceleração e preparação emocional para o processo de cuidado.

De forma complementar, a Arquitetura Sensorial amplia a percepção do espaço para além da dimensão visual, incorporando estímulos táteis, olfativos e corporais. A presença de jardins e hortas permite a aproximação direta com o alimento e com o ciclo natural, transformando o ambiente em um suporte ativo de aprendizado, sensibilização e reconexão com a alimentação.

O Design Holístico, por sua vez, integra essas dimensões em um sistema contínuo, articulando cuidado, educação e convivência, de modo a garantir a relação entre aspectos físicos, emocionais e sociais no uso do espaço, bem como sua resposta às diferentes necessidades dos usuários ao longo do processo.

A convergência desses conceitos materializa a síntese deste projeto: a transição de um modelo de saúde institucional para um território de cura. O ambiente construído deixa de ser um suporte neutro para se tornar o mediador que reconecta o sujeito ao alimento, transformando o ato de nutrir-se em um processo de autonomia e pertencimento social.

Diagramas



Referências

ASBAI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA. Alergia alimentar no Brasil: dados epidemiológicos e impacto clínico. São Paulo: ASBAI, 2023.

BAYER. Dados sobre intolerância à lactose no Brasil. São Paulo: Bayer, 2018.

FLEURY. Esofagite eosinofílica: prevalência e aspectos clínicos. São Paulo: Grupo Fleury, 2024.

IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018: análise do consumo alimentar no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

KELLERT, Stephen R. The Practice of Biophilic Design. London: Routledge, 2015.

LIMA, T. F. Alimentação, ambiente e qualidade de vida. São Paulo: [s.n.], 2020.

LIMA, T. F. Humanização e cuidado em saúde: a cura além da dor física. [S.l.: s.n.], 2012.

MONTEIRO, Carlos A. *et al.* Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system. Public Health Nutrition, [S.l.], v. 22, n. 10, p. 1918-1927, 2019.

MULLER, J.; NOGUEIRA, R. Ambiência em espaços de saúde e modelo biomédico tradicional. [S.l.: s.n.], 2026.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Noncommunicable diseases (NCDs): key facts. Geneva: WHO, 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE GASTROENTEROLOGIA. Doença Celíaca: dados epidemiológicos globais. [S.l.]: WGO, 2023.

PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Bookman, 2011.

PEREIRA, R. Transformações alimentares e impactos dos alimentos ultraprocessados. [S.l.: s.n.], 2013.

SES/SC – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA.
Dados de mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
Florianópolis: SES/SC, 2023.

ULRICH, Roger S. Effects of healthcare environmental design on medical outcomes. *In*: Proceedings of the Design and Health World Congress. Stockholm: [s.n.], 1991.